DOI:10.16662/j.cnki.1674-0742.2025.02.094

阶梯式言语康复护理对老年帕金森病言语障碍患者言语功能恢复的影响

钱坤,沈敏,聂玉静
徐州医科大学附属医院神经内科,江苏 徐州 221000

[摘要] **目的** 探究老年帕金森病言语障碍患者应用阶梯式言语康复护理对言语功能恢复的影响。**方法** 方便选取2021年3月—2023年3月徐州医科大学附属医院收治的104例老年帕金森病言语障碍患者为研究对象,根据护理方法不同分为两组,每组52例。进行常规护理的为对照组,在对照组基础上加用阶梯式言语康复护理的是观察组。对两组言语功能、生活质量及护理满意度进行比较。**结果** 护理后,与对照组比,观察组言语功能评分更低,生活质量评分更高,差异均有统计学意义(P均<0.05)。观察组护理满意度为100.00%(52/52),高于对照组的88.46%(46/52),差异有统计学意义(χ^2=4.422,P<0.05)。**结论** 针对老年帕金森言语障碍患者采取阶梯式言语康复护理有助于改善患者的言语功能,并提高患者的生活质量,护理满意度更高。

[关键词] 老年帕金森;言语障碍;阶梯式言语康复护理;言语功能;生活质量
[中图分类号] R47 [文献标识码] A [文章编号] 1674-0742(2025)01(b)-0094-04

The Impact of Stepped Speech Rehabilitation Nursing on the Recovery of Speech Function in Elderly Parkinson´s Disease Patients with Speech Disorders

QIAN Kun, SHEN Min, NIE Yujing
Department of Neurology, Affiliated Hospital of Xuzhou Medical University, Xuzhou, Jiangsu, 221000, China

[Abstract] Objective To explore the effect of stepped speech rehabilitation nursing on the recovery of speech function in elderly patients with Parkinson′s disease. **Methods** A total of 104 elderly patients with speech disorder of Parkinson′s disease admitted to the Affiliated Hospital of Xuzhou Medical University from March 2021 to March 2023 were conveniently selected as the research objects. According to different nursing methods, assigned to two groups, with 52 cases in each group. The control group was given routine nursing, and the observation group received stepped speech rehabilitation nursing on the basis of the control group. The speech function, quality of life and nursing satisfaction were compared between the two groups. **Results** After nursing, compared with control group, the speech function score of the observation group was lower, and the quality of life score was higher, the differences were statistically significant (all P<0.05). The nursing satisfaction of the observation group 100.00% (52/52) was higher than that of the control group 88.46% (46/52), and the difference was statistically significant (χ^2=4.422, P<0.05). **Conclusion** Stepped speech rehabilitation nursing for elderly patients with Parkinson′s speech disorder is helpful to improve the speech function of patients, improve the quality of life of patients, and have higher nursing satisfaction.

[Keywords] Parkinson′s disease in the elderly; Speech disorders; Stepped speech rehabilitation nursing; Speech function; Quality of life

帕金森病是一种神经系统疾病,会影响患者的运动能力和语言功能[1]。其中,言语障碍在帕金森患者中较为常见,发生率约为70%[2]。其主要原因为中枢机制异常、听觉反馈受损、周围运动障碍等。

[作者简介] 钱坤(1989—),女,本科,主管护师,研究方向为神经内科护理。

中国知网 https://www.cnki.net

患者表现为声音嘶哑、含糊不清、说话时语调单一、音量控制不准确等。这些症状会影响患者的交流能力，导致沟通困难[3]。由于语言交流困难，患者难以参与社交活动和工作，因而可能会感到孤独和沮丧，加重了家庭和社会的负担[4]。尽管药物治疗能够改善患者的运动障碍，但并不能完全治愈其言语障碍[5]。有研究认为，通过康复护理，能够在一定程度上缓解患者的言语功能和生活质量[6]。随着医疗护理服务的创新，阶梯式护理服务逐渐应用于临床中[7]。基于该模式下的护理服务根据患者的恢复进展，以不断提高护理级别。除提高患者的生活质量外，有助于提高医疗资源的利用率[8]。因此，本研究方便选取2021年3月—2023年3月徐州医科大学附属医院收治的104例老年帕金森病言语障碍患者为研究对象，探究阶梯式言语康复护理的作用。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

方便选取本院收治的104例老年帕金森病言语障碍患者为研究对象，按照护理方法的不同分为对照组、观察组，各52例。对照组：男33例，女19例；年龄50~82岁，平均（59.62±5.21）岁；文化程度：小学及以下25例，初中19例，高中及以上8例。观察组：男31例，女21例；年龄51~80岁，平均（59.28±5.06）岁；文化程度：小学及以下24例，初中20例，高中及以上8例。两组性别、年龄等对比，差异均无统计学意义（P均>0.05），具有可比性。本研究经徐州医科大学附属医院医学伦理委员会批准（XY20210215-01）。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准：①确诊为帕金森病[9]；②嗓音障碍评定量表（Voice Handicap Index, VHI）[10]>75分；③年龄≥50岁；④患者知情同意本研究。

排除标准：①既往有精神病史或严重意识模糊者；②患有喉癌、声带小结及其他影响言语表达的疾病者。

1.3 护理方法

对照组采取常规护理。主要包括：①健康宣教。向患者及家属介绍帕金森病的病因、发病机制、临床表现、治疗方法及康复训练等方面的知识，以帮助患者及家属全面了解该疾病。在心理层面，安慰患者及家属，解释言语障碍只不过是帕金森的一种表现，减少其对病情的误解和恐惧。②言语功能训练。指导患者进行发音训练、口语表达训练、认知功能训练，1次/d，30 min/次。发音训练：包括音素发音练习、音节发音练习。口语表达训练：包括口部肌肉和口语表达练习。认知功能训练：包括阅读、听力和逻辑推理练习。连续锻炼3个月。

观察组在对照组基础上实施阶梯式言语康复护理。具体流程包括：成立阶梯式言语康复护理小组，组长由护士长担任。负责整个护理小组的协调和管理。护士4名，负责指导患者进行言语康复训练。评估患者言语功能，并进行分级。

基础康复训练。①语音训练。3次/d，25 min/次。训练内容：音素发音练习：针对患者发音不清的音素进行重点练习，如唇齿音、舌齿音；音节发音练习：练习常见的音节组合，如“ba”“da”“ga”等；单词和句子发音练习：通过练习常用的单词和句子，提高患者的整体语音清晰度。音调、音量、语速控制：针对患者的音调、音量和语速进行控制训练，提高患者的语言可理解性。②口部肌肉训练。2次/d，15 min/次。具体内容：指导患者进行张口、闭口、咬合、吸吮等基本口部肌肉运动；指导患者学习控制口部肌肉能力，如吹气、鼓腮、舌部运动等。

强化康复训练。当患者满足口部肌肉力量协调性，并具备一定的语音清晰度后，采取进阶训练。①口语表达训练。3次/d，25 min/次。内容：口语表达技巧训练：教授患者口语表达的技巧，如语速控制、语调变化等；口语组织能力训练：模拟日常生活中的交流场景进行对话练习，提高患者的口语交流能力。②认知功能训练。进行3~4次/周，约30 min/次。具体内容：指导患者通过电子读物阅读文章或APP听故事，并对故事进行复述，以提高阅读能力。通过记忆数字、图像、故事等方式，提高记忆能力。如患者完成度较高，可适当指导其进行逻辑推理，倒背数字练习，以提高思维能力。连续护理3个月。③精神鼓励。患者在完成每天的训练后，医护人员和家属应肯定患者的努力和进步，对于存在较强挫败感的患者，对其提供心理疏导，并建议其与病友进行交流，共克难关。

1.4 观察指标

1.4.1 言语功能 护理前及护理3个月后，通过VHI[10]评估发声问题对生活的影响程度，总分0~120分，分值越高影响越严重。采用帕金森病评定量表（The Unified Parkinson's Disease Rating Scale-Part Ⅲ, UPDRS-Ⅲ）[11]中的运动检查部分的言语（表达）

中国知网 https://www.cnki.net

评估两组语言功能恢复情况，0分表示正常，1分为表达、理解或音量轻度下降，单音调、含糊但可听懂，中度受损为2分，明显损害为3分，无法听懂为4分。

1.4.2 生活质量 通过生活质量评定问卷（General Quality of Life Inventory-74, GQOLI-74）[12]评估两组生活质量，包括躯体功能、心理功能、社会功能。分值均为0~100分，分数越高生活质量越好。

1.4.3 护理满意度 采用本院自制护理满意度调查表评估两组家属对护理服务的评价，分值0~100分，Cronbach α系数为82.36%，包括不满意（0~75分）、满意（76~90分）、非常满意（91~100分）。护理总满意度=1-不满意率。

1.5 统计方法

数据分析应用SPSS 26.0统计学软件，用例数（n）和率（%）表示计数资料（护理满意度），行χ^2检验；用（$\bar{x}\pm s$）表示符合正态分布的计量资料（VHI、UPDRS-Ⅲ、GQOLI-74），组间比较行独立样本t检验，组内比较行配对t检验。$P<0.05$为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者言语功能对比

护理前，两组言语功能对比，差异无统计学意义（$P>0.05$）；两组护理后VHI、UPDRS评分均降低，观察组评分均低于对照组，差异均有统计学意义（P均<0.05）。见表1。

表1 两组患者言语功能对比[（$\bar{x}\pm s$），分]

组别	VHI评分		UPDRS-Ⅲ评分	
	护理前	护理3个月	护理前	护理3个月
对照组（n=52）	82.06±3.31	46.51±5.52[a]	3.06±0.47	2.59±0.41[a]
观察组（n=52）	81.95±3.41	35.21±5.06[a]	3.08±0.51	1.82±0.59[a]
t值	0.167	10.882	0.208	7.728
P值	0.868	<0.001	0.836	<0.001

注：VHI为嗓音障碍评定量表，UPDRS-Ⅲ为语言表达量表；与同组护理前相比，[a]$P<0.05$。

2.2 两组患者生活质量对比

护理前，两组GQOLI-74评分对比，差异无统计学意义（$P>0.05$）；护理后，两组GQOLI-74评分升高，观察组高于对照组，差异均有统计学意义（P均<0.05）。见表2。

表2 两组患者GQOLI-74量表评分对比[（$\bar{x}\pm s$），分]

组别	躯体功能		心理功能		社会功能	
	护理前	护理3个月	护理前	护理3个月	护理前	护理3个月
对照组（n=52）	62.31±4.21	75.23±3.35[a]	56.23±5.02	70.26±7.25[a]	52.16±3.95	71.25±4.02[a]
观察组（n=52）	62.28±4.15	80.06±3.67[a]	56.12±4.95	80.05±8.05[a]	52.08±3.74	78.56±3.37[a]
t值	0.037	7.009	0.113	6.517	0.106	10.049
P值	0.971	<0.001	0.911	<0.001	0.916	<0.001

注：GQOL-I 74为生活质量评定问卷；与同组护理前相比，[a]$P<0.05$。

2.3 两组患者护理满意度对比

与对照组相比，观察组护理满意度更高，差异有统计学意义（$P<0.05$）。见表3。

表3 两组患者护理满意度对比

组别	非常满意（n）	满意（n）	不满意（n）	总满意率（%）
对照组（n=52）	20	26	6	88.46
观察组（n=52）	23	29	0	100.00
χ^2值				4.422
P值				0.035

3 讨论

对于老年帕金森病言语障碍患者而言，需要长期服用药物来控制症状[13]。但药物治疗可能导致不良反应发生，如睡眠障碍、胃肠道反应和直立性低血压等，随着时间的推移药物治疗的效果也会减弱[14]。因此，对于言语障碍患者，康复护理确有必要[15]。有文献指出，阶梯式护理是一种结构化、分阶段的护理方式，其核心思想是根据患者病情和康复进程的不同阶段，制订并实施相应的护理措施[16]。在老年帕金森病言语障碍患者中，由于患者语言功能恢复程度不一，因此康复训练的计划也应随着患者的言语功能水平进行调整[17]。基于此，阶梯式言语康复护理或许能够作为一种应用价值较高的护理模式[18]。

本研究结果显示，观察组VHI评分、UPDRS评分均优于对照组（P均<0.05）。刘立[19]的研究结果同样显示，观察组VHI评分、UPDRS评分均优于对照组（P均<0.05）。究其原因：在本研究中，根据患者不同的言语功能状况，对患者实施阶梯式护理。

中国知网 https://www.cnki.net

这种分类护理的方法能够更好地满足不同患者的需求，避免一刀切的护理方式，使护理更加精细化。对于基础康复，采取语音训练和口部肌肉训练。在语音训练注重音素、音节、单词和句子的发音练习，有助于提高患者的语音清晰度。而口部肌肉训练则通过基本的运动和肌肉控制练习，帮助患者恢复和增强口部肌肉的力量和协调性。对于满足一定条件的患者，进行强化康复，其中引入了口语表达训练和认知功能训练。这些训练内容不仅关注语音的表达，还注重口语交流和认知能力的提升。口语表达训练通过教授技巧和提高组织能力，增强患者日常交流的信心和能力。认知功能训练则通过阅读、记忆和逻辑推理的练习，全面提升患者的认知水平。本研究中，观察组护理后GQOLI-74量表评分高于对照组，护理总满意率高于对照组（P均<0.05）。周斌等[20]的研究结果指出，观察组GQOLI-74量表评分高于对照组，且对照组护理总满意率低于观察组（P均<0.05）。这意味着阶梯式护理不仅对患者的言语功能恢复有积极影响，还可改善整体生活质量。由于提升了患者的口语表达能力和交流能力，患者的社交功能获得改善，心理状态也有所调整。因此，患者家属对护理服务的评价也会更高[21]。

综上所述，老年帕金森病言语障碍患者在经过阶梯式护理后言语功能恢复较好，且生活质量得到较大改善，护理满意度更高。

[参考文献]

[1] 范萍,顾文涛,刘卫国.统一帕金森病评定量表评估无言语障碍帕金森病患者的语音声学特征[J].听力学及言语疾病杂志,2022,30(3):262-265.

[2] 蔡吴蔚艳,肖永涛.帕金森病患者言语语言障碍的研究进展[J].中国医药科学,2021,11(6):47-50.

[3] 阳杨,庞子建,高立群.帕金森病言语障碍特征性表现及干预治疗研究进展[J].听力学及言语疾病杂志,2023,31(1):6.

[4] 靳雨,陈卉.阶梯式言语康复联合抗阻运动规律康复训练对帕金森病患者的影响[J].国际护理学杂志,2023,42(19):3510-3515.

[5] 郭兰华,孙欢.阶梯式言语康复护理对老年帕金森病患者言语功能的改善效果研究[J].健康必读,2022(13):111-112,117.

[6] 王晓雯,朱青青,陈艳,等.高频重复经颅磁刺激联合嗓音训练对帕金森病患者嗓音功能的影响[J].康复学报,2022,32(2):155-161.

[7] 丁松奇.阶梯式言语康复锻炼护理在帕金森病言语障碍患者护理中的临床效果[J].辽宁医学杂志,2023,37(3):97-100.

[8] 丁帅燕,汤云.阶梯式言语康复护理对老年帕金森病患者言语功能的影响[J].中文科技期刊数据库(引文版·医药卫生),2023(11):137-140.

[9] 陈海波,武冬冬.帕金森病基层诊疗指南(2019年)[J].中华全科医师杂志,2020(1):5-6.

[10] 李红艳,徐文,胡蓉,等.嗓音障碍指数量表简化中文版的研究[J].听力学及言语疾病杂志,2010,18(6):566-570.

[11] Movement Disorder Society Task Force on Rating Scales for Parkinson's Disease. The Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS): Status and recommendations[J].Mov Disord,2003,18(7):738-750.

[12] 李凌江,杨德森.生活质量综合评定问卷[J].临床荟萃,2009,24(9):763.

[13] 吴琪,庄红霞,荆晓雷,等.阶梯式言语康复护理对帕金森病言语障碍患者的应用[J].安徽卫生职业技术学院学报,2020,19(2):63-64,67.

[14] 杜晓航,施煜,王丽瑛,等.Snyder希望理论联合微信群在老年帕金森患者中的应用[J].重庆医学,2023,52(S1):122-125.

[15] 阳杨,甘莉,庞子建,等.帕金森病动作语言障碍及相关神经联动机制研究进展[J].中国听力语言康复科学杂志,2023,21(1):61-64.

[16] 崔倩.阶梯式言语康复护理干预对帕金森病言语障碍患者的效果[J].中外女性健康研究,2022(21):160-161.

[17] 张国艳.阶梯式言语康复护理对老年帕金森病患者言语功能的影响[J].基层医学论坛,2022,26(3):96-98.

[18] 赵雪.阶梯式言语康复护理干预在帕金森病言语障碍患者中的应用效果[J].中国当代医药,2021,28(1):233-235.

[19] 刘立.阶梯式言语康复护理对帕金森病言语障碍患者的改善价值[J].中国实用医药,2020,15(35):188-190.

[20] 周斌,张佳佳.阶梯式言语康复护理对帕金森病言语障碍患者的应用效果评价[J].中华养生保健,2023,41(14):119-122.

[21] 邵秋颖,侯青,张莲,等.阶梯式言语康复干预在帕金森言语障碍患者中的应用效果[J].河北医药,2022,44(18):2794-2796,2800.

（收稿日期：2024-01-26）

中国知网 https://www.cnki.net